

SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON Y NECRÓLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA

Pablo Chicharro, Pedro Rodríguez-Jiménez, Ester Muñoz-Aceituno.

INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y la Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) son cuadros infrecuentes, pero que pueden tener una elevada mortalidad. Se diferencian clínicamente en el porcentaje de superficie corporal afectada, con un incremento proporcional de la mortalidad. Ambos son más frecuentes en mujeres y pacientes inmunocomprometidos. En la mayoría de los casos están desencadenados por un agente farmacológico, especialmente en la NET, siendo los más frecuentes: alopurinol, antibióticos, AINEs y anticonvulsivantes. El riesgo es máximo en la primera semana de tratamiento. Tras la exposición al fármaco, se desencadena una reacción de hipersensibilidad con la apoptosis masiva de queratinocitos que provoca la necrólisis epidérmica responsable del cuadro clínico.

Los síntomas iniciales suelen consistir en fiebre, sensación de cuerpo extraño ocular y odinofagia, que preceden de 1 a 3 días a la afectación cutánea. Las lesiones suelen iniciarse como máculas eritemato-violáceas, con tendencia a la coalescencia, afectando al tronco, con extensión progresiva cefálica y a región proximal de extremidades. Las palmas y plantas también pueden afectarse y hacerlo de forma temprana. Las lesiones progresan hacia máculas de coloración grisácea en horas o días, con formación paralela a la necrosis de ampollas flácidas, frágiles y con signo de Nikolsky positivo, otorgando un aspecto de piel escaldada. En la mayoría de los pacientes hay eritema y erosiones de mucosa orogenital y oculares, siendo la afectación de mucosas muy dolorosa. Además de la fiebre, entre las manifestaciones sistémicas se incluyen: tos, disnea, dolor abdominal, diarrea y adenopatías.



DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de SSJ y NET es fundamentalmente clínico. Ante la aparición de lesiones cutáneas compatibles, afectación de mucosas y la introducción reciente de fármacos sospechosos, debemos establecer la sospecha clínica y no postponer el resto del abordaje diagnóstico-terapéutico. Según el porcentaje corporal afectado tendremos tres categorías:

- 1) Menos del 10%: SJS.
- 2) 10-30%: Solapamiento SJS/NET.
- 3) Más del 30%: NET. Una mayor afectación implica un peor pronóstico y, por lo tanto exige un abordaje más agresivo.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico es clínico y se confirma con la biopsia cutánea, dentro del diagnóstico diferencial se encuentra:

- Eritema multiforme
- Transtornos ampollosos primarios
- Eritemas infecciosos tóxicos
- Enfermedad de Kawasaki
- Dermatitis exfoliativa

Pruebas complementarias

En el estudio complementario inicial se debe incluir:

- Hemograma (descartar citopenias)
- Coagulación (coagulopatía de consumo)
- Bioquímica (valoración de función renal, hidroelectrolitos, colestasis y citólisis). Glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, PCR.
- Radiografía de tórax postero anterior y lateral. Si hay sintomatología respiratoria, se debe realizar una radiografía de tórax ante el riesgo de progresión a distrés respiratorio.
- Ingresado en planta/UCI. El estudio histopatológico será de confirmación, mostrando necrosis de queratinocitos epidérmicos, con formación de ampollas subepidérmicas y con inmunofluorescencia negativa.



TRATAMIENTO

El tratamiento de ambos cuadros, fundamentalmente de la NET, debe ser inmediato ante la sospecha diagnóstica y seguirá las mismas premisas que el de grandes quemados. En primer lugar y si conocemos el fármaco responsable, se procederá a su retirada. Si la superficie corporal

afectada es mayor al 20%, se recomienda el manejo en una unidad de cuidados intensivos. Se debe realizar un adecuado aporte volémico, con corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas. Se prestará especial atención al riesgo de sobreinfección bacteriana, aplicando antibióticos tópicos de forma profiláctica (mupirocina o ácido fusídico) e instaurando antibioterapia sistémica precozmente si hay datos de sobreinfección, previa toma de cultivos. En el cuidado tópico se pueden realizar lavados con soluciones de suero salino isotónico, aplicando posteriormente vaselina no perfumada, especialmente en zonas de presión. Se manipulará mínimamente al paciente y bajo medidas tan asépticas como sea posible. Puede ser necesaria la valoración especializada oftalmológica y el empleo de colirios antibióticos. Respecto a tratamientos específicos no existe ninguna evidencia establecida, con una alta controversia respecto al empleo de corticoides. Si se considera su empleo, se recomiendan pulsos cortos de 3 días con dexametasona (1,5mg/kg/día). El empleo de inmunoglobulinas intravenosas también puede frenar la progresión de la enfermedad (>2g/kg dosis total, repartida en 3-4 días).

ALERTA

- Debido a su elevada mortalidad, ésta es una auténtica emergencia dermatológica. No debemos retrasar el tratamiento y las primeras pruebas complementarias en un paciente que presenta lesiones cutáneas compatibles, lesiones en mucosas u oculares, y un antecedente farmacológico reciente.

BIBLIOGRAFÍA

- Lerch M, Mainetti C, Terzioli Beretta-Piccoli B, Harr T. Current perspectives on Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. Clin Rev Allergy Immunol. 2018;54(1):147-176.
- Dodiuk-Gad RP, Chung WH, Valeyrie-Allanore L, Shear NH. Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: an update. A J Clin Dermatol. 2015;16(6):475-93.
- Downey A, Jackson C, Harun N, Cooper A. Toxic epidermal necrolysis: review of pathogenesis and management. J Am Acad Dermatol. 2012;66(6):995-1003.